Hồ sơ thực hiện tiêu chí A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

Dự thảo trình duyệt năm 2026. Bộ hồ sơ cung cấp ma trận yêu cầu, quy định triển khai đề xuất, kế hoạch, chỉ số và biểu mẫu để các đơn vị bổ sung minh chứng thực tế. Chưa có căn cứ kết luận mức đạt của bệnh viện.

Số văn bản và phiên bản .....

Ngày phê duyệt và áp dụng .....

Người soạn thảo .....

Người rà soát .....

Người phê duyệt .....

Đầu mối và cách sử dụng

Phòng Kế hoạch tổng hợp và QLCL phối hợp Phòng Điều dưỡng, CNTT, các khoa và bộ phận bảo vệ. Đây là phân công đề xuất, phải xác nhận với cơ cấu và thẩm quyền thực tế trước ký.

Không ghi lùi ngày, tạo chữ ký hoặc điền số liệu thay cho hoạt động chưa thực hiện. Mã biểu mẫu là mã đề xuất, cần thống nhất với quản lý tài liệu bệnh viện. Hồ sơ tiêu chí quản lý không bị ép theo đề cương quy trình kỹ thuật QĐ3023.

1 Căn cứ và nguyên tắc đối chiếu

Căn cứ trực tiếp: QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, A4.2, trang in 35–36 [1]. Ma trận sau diễn giải rút gọn, giữ số mục và mức để tra cứu cùng bản gốc.

Bộ phận QLCL và pháp chế đối chiếu thêm hướng dẫn kiểm tra của kỳ đánh giá thực tế; không mặc định mọi viện dẫn trong phần căn cứ lịch sử năm 2016 còn hiện hành. Các nội dung quyền người bệnh thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và văn bản liên quan hiện hành.

Kiểm tra tình trạng bất lợi mức 1 trước. Khi có tình trạng mức 1, xử lý và đánh giá theo hướng dẫn của Bộ tiêu chí; không biến tình trạng đó thành yêu cầu tích cực. Nếu không có tình trạng mức 1, đối chiếu tích lũy mức 2–5, không lấy trung bình số ô đáp ứng để xếp mức.

Ngưỡng trên 13 tuổi và khoảng cách tối thiểu một mét ở đây là yêu cầu cụ thể của A4.2. Kiểm tra đồng thời A2.1 khi bố trí buồng và giường; không dùng một bức rèm để mặc định đạt yêu cầu buồng nam nữ riêng ở mức 5.

Cập nhật bảo vệ dữ liệu theo Luật 91/2025/QH15 và NĐ356/2025/NĐ-CP từ 01/01/2026. NĐ13/2023/NĐ-CP đã hết hiệu lực theo khoản 2 Điều 42 NĐ356; không viện dẫn như căn cứ hiện hành độc lập.

Căn cứ xử lý thông tin chuyên môn, tiếp cận bệnh án và ngoại lệ luật định cần pháp chế xác minh. Đồng ý chụp ảnh điều trị không đồng nghĩa đồng ý đăng truyền thông; không dùng một cam kết chung để hợp thức hóa mọi mục đích.

2 Ma trận tiểu mục 1 đến 10

Mục mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
1 M1	Có vi phạm quyền riêng tư gây khiếu kiện và xác minh có sai phạm của bệnh viện	Hồ sơ tiếp nhận, xác minh và xử lý.
2 M2	Có quy định quản lý, lưu trữ bệnh án chặt chẽ	Quy định, phân quyền, nơi lưu.
3 M2	Bệnh án gọn gàng, người không có thẩm quyền không tự do tiếp cận	Quan sát tủ, màn hình và quyền truy cập.
4 M2	Khoa phân công người trực giữ, bảo quản bệnh án	Phân công ca và bàn giao.
5 M2	Bảo mật thông tin nhạy cảm; chỉ cung cấp đúng đối tượng, sự đồng ý hoặc căn cứ có thẩm quyền	Yêu cầu, căn cứ chia sẻ và nhật ký cung cấp.
6 M2	Tôn trọng quyền từ chối chụp ảnh, trừ yêu cầu chuyên môn theo tiêu chí	Giải thích mục đích, cơ sở xử lý và phạm vi sử dụng.
7 M2	Xin phép và có đồng ý trước thực tập hoặc thị phạm trên cơ thể	Ghi nhận chấp thuận và người tham gia.
8 M2	Bảo vệ người bệnh khỏi chụp ảnh tự do, bảo mật hình ảnh	Quy định, kiểm soát khách và xử lý sự việc.
9 M3	Không lộ thông tin cá nhân trên truyền thông về điều trị, trừ được đồng ý	Rà soát nội dung, chấp thuận và phản ánh.
10 M3	Phòng khám, cận lâm sàng, thủ thuật có vách hoặc rèm kín khi bộc lộ cơ thể	Quan sát và bảng kiểm từng khu.

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

2 Ma trận tiểu mục 11 đến 18

Mục mức	Nội dung đối chiếu	Minh chứng cần có
11 M3	Sẵn vách hoặc rèm di động tại khoa cho khám, thay đồ, vệ sinh tại giường	Kiểm kê và kiểm tra sử dụng.
12 M3	Phiếu đầu giường không chi tiết hóa bệnh có thể gây bất lợi cho người bệnh	Mẫu thông tin và quan sát.
13 M4	Có khu nam nữ riêng cho người trên 13 tuổi và vách/rèm giữa hai khu	Sơ đồ và quan sát thực tế.
14 M4	Có nơi thay đồ kín đáo cho dịch vụ yêu cầu thay quần áo	Kiểm tra từng phòng.
15 M5	Có khăn, áo hoặc váy che kín khi khám sản phụ khoa, bộ phận sinh dục	Phương tiện, làm sạch và thực hành.
16 M5	Mỗi giường có rèm đóng mở khi cần	Kiểm kê và sử dụng thực tế.
17 M5	Người trên 13 tuổi nằm buồng nam nữ riêng	Danh sách và kiểm tra.
18 M5	Khoảng cách giữa hai giường tối thiểu một mét khi buồng có từ hai giường	Đo, ghi vị trí và biên bản.

Kết quả từng dòng: ghi tại phiếu tự đánh giá cuối hồ sơ. Dẫn mã minh chứng và vị trí tra cứu; quan sát một thời điểm không thay thế yêu cầu theo dõi cả năm khi tiêu chí có quy định.

3 Quy định triển khai đề xuất

Mục tiêu: Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư. Phạm vi bao gồm các đơn vị liên quan trực tiếp và bộ phận hỗ trợ. Ban Giám đốc phê duyệt quy định, nguồn lực và phân cấp; trưởng đơn vị tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý phát sinh; QLCL tổng hợp kết quả và theo dõi cải tiến.

Kiểm tra quyền riêng tư trước chăm sóc

Giải thích việc cần làm, xin phép phù hợp, đóng cửa/rèm và chỉ bộc lộ phần cần thiết; hạn chế người không có phận sự. Đánh giá nhu cầu người hỗ trợ/chứng kiến khi khám nhạy cảm theo quy định bệnh viện và nguyện vọng phù hợp.

Bảo quản hồ sơ giấy và điện tử

Phân công người quản lý mỗi ca; không để hồ sơ hoặc màn hình lộ tại nơi công cộng. Tài khoản cá nhân theo vai trò, không chia sẻ mật khẩu; khóa màn hình, kiểm soát in sao và lưu nhật ký truy cập theo hệ thống thực tế.

Tiếp nhận yêu cầu chia sẻ

Xác minh danh tính, quyền đại diện, nội dung, mục đích và cơ sở pháp lý; chỉ chia sẻ phần cần thiết qua kênh được phép. Không cung cấp cho người tự xưng thân nhân khi chưa xác minh. Hồ sơ trẻ em và người cần đại diện phải xử lý đúng pháp luật.

4 Xử lý tình huống và kiểm soát thực hiện

Quản lý hình ảnh và thực tập

Giải thích mục đích, người tiếp cận, nơi lưu và phạm vi sử dụng. Xin đồng ý phù hợp trước hoạt động giảng dạy hoặc truyền thông; việc từ chối không làm giảm quyền được chăm sóc. Ngăn quay/chụp tùy tiện; không đăng ảnh nhận diện người bệnh vào nhóm cá nhân.

Xử lý vi phạm và cải tiến

Bảo vệ người bệnh, hạn chế truy cập hoặc phát tán, lưu chứng cứ theo thẩm quyền, báo đầu mối phụ trách; đánh giá nghĩa vụ thông báo và khắc phục theo pháp luật hiện hành. Không tự xóa dấu vết hoặc chỉ yêu cầu người đăng gỡ bài rồi kết thúc xử lý.

Ghi nhận và kiểm soát minh chứng

Ghi đúng thời điểm, người thực hiện, kết quả và việc chưa hoàn thành. Phân quyền truy cập, dùng mã thay dữ liệu định danh trong báo cáo tổng hợp; giữ hồ sơ chi tiết ở nơi được phép. Chứng cứ ảnh phải có bối cảnh, thời gian và mục đích phù hợp, không công khai thông tin người bệnh trái quy định.

Tài liệu và bảng nhắc cần được rà soát chuyên môn, phê duyệt đúng thẩm quyền, cấp phiên bản và phổ biến. Khi thay đổi phải thu hồi bản cũ và hướng dẫn lại. Đào tạo có nội dung, danh sách tham dự thật, kiểm tra khả năng thực hiện và kế hoạch học bù.

5 Kế hoạch triển khai và đo lường

T0 là ngày phê duyệt thực tế. Lịch dưới đây là đề xuất để đơn vị điều chỉnh theo nguồn lực; không phải lịch bắt buộc do Bộ tiêu chí ấn định.

Thời hạn	Công việc	Sản phẩm
T0 + 15 ngày	Khảo sát từng tiểu mục, xác định khoảng thiếu.	Dữ liệu nền và phân công.
T0 + 30 ngày	Trình quy định, công cụ, nguồn lực và đào tạo.	Văn bản được duyệt và hồ sơ phổ biến.
T0 + 60 ngày	Triển khai, kiểm tra thực hành, ghi dữ liệu.	Biểu mẫu thực tế và xử lý tồn tại.
T0 + 90 ngày	Đánh giá, phản hồi, cải tiến và đo lại.	Báo cáo và hành động theo dõi.

Bảo đảm che chắn khi cần

Số lượt quan sát có bảo đảm kín đáo / tổng lượt cần che chắn đã quan sát × 100%; nêu rõ cách chọn mẫu.

Khu vực và giường có phương tiện

Đếm từng phòng, giường và phương tiện dùng được; đối chiếu riêng các mục 10, 11, 14, 15 và 16, không gom một tỷ lệ để kết luận tất cả đạt.

Phản ánh và vi phạm dữ liệu

Số phản ánh, số được xác minh có vi phạm, loại dữ liệu, biện pháp và trạng thái; không có đơn không tự chứng minh không có vi phạm.

Trước đo phải khóa định nghĩa, kỳ, mẫu số và cách chọn đối tượng. Mẫu số bằng 0 ghi không tính được; thiếu dữ liệu ghi chưa xác minh. Không làm tròn dưới ngưỡng thành đạt hoặc suy rộng một mẫu nhỏ thành toàn bộ bệnh viện.

6 BM01 Kiểm tra không gian và che chắn

Mã đề xuất A42 BM01.

Đơn vị, phòng, ngày, người kiểm tra và thiết bị đo nếu có .....

Người ghi và đơn vị .....

Vị trí hoặc giường	Rèm, thay đồ, nam nữ	Khoảng cách thực đo	Khắc phục và hạn

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM02 Kiểm soát cung cấp thông tin

Mã đề xuất A42 BM02.

Mã hồ sơ, ngày và người xử lý; lưu trong khu vực phân quyền .....

Người ghi và đơn vị .....

Người yêu cầu và xác minh	Phạm vi, mục đích	Đồng ý hoặc căn cứ pháp lý	Cấp thông tin và nhật ký

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM03 Ghi nhận đồng ý theo mục đích

Mã đề xuất A42 BM03.

Mã người bệnh; người đại diện và căn cứ nếu có .....

Người ghi và đơn vị .....

Mục đích cụ thể	Ảnh, thông tin, phạm vi dùng	Giải thích và lựa chọn	Người ghi, ngày, xác nhận

Lựa chọn sau giải thích: □ Đồng ý trong phạm vi ghi rõ □ Không đồng ý □ Cần giải thích thêm. Không đánh dấu sẵn. Thông tin về thời hạn lưu, người tiếp cận, kênh sử dụng và cách liên hệ để thực hiện quyền: .....

Mẫu ghi nhận bổ trợ, không thay thế mẫu chấp thuận chuyên biệt hoặc xác minh căn cứ pháp lý. Không gộp đồng ý điều trị với đồng ý quảng bá hình ảnh.

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

6 BM04 Theo dõi phản ánh và khắc phục

Mã đề xuất A42 BM04.

Kỳ, đầu mối tiếp nhận; không đưa dữ liệu nhạy cảm vào báo cáo công khai .....

Người ghi và đơn vị .....

Sự việc và thời điểm	Xác minh, mức ảnh hưởng	Xử lý và trách nhiệm	Đo lại và kết luận

Nhận xét, tồn tại hoặc thông tin cần xác minh .....

Hành động tiếp theo, người phụ trách và hạn .....

Người kiểm tra, ngày và kết quả xác nhận .....

Ghi theo thực tế, không xác nhận trước; lưu trong hệ thống được phân quyền. Cần thêm dòng thì sao chép trang biểu mẫu hoặc tích hợp vào hệ thống chính thức.

7 Danh mục minh chứng và tự đánh giá

Nhóm	Hồ sơ cần tập hợp	Mã và vị trí
MC01	Quy định, quyết định phân công, nguồn lực và phê duyệt.	
MC02	Hồ sơ phổ biến, đào tạo, kiểm tra thực hành và học bù.	
MC03	Biểu mẫu đã thực hiện, dữ liệu nguồn, quan sát và phỏng vấn.	
MC04	Chỉ số, báo cáo, phản hồi, cải tiến và đo lại.	
MC05	Hồ sơ phản ánh, sự cố và xác minh tình trạng mức 1.	

Kỳ đánh giá và phạm vi .....

Tình trạng mức 1 và bằng chứng xác minh .....

Mức đề xuất sau kiểm tra tích lũy .....

Khoảng thiếu và người chịu trách nhiệm .....

Người lập và người kiểm tra .....

Có bộ hồ sơ không đồng nghĩa đạt tiêu chí. Phải kiểm tra hoạt động tại hiện trường và đối chiếu dữ liệu nguồn; các trường hợp chưa xác minh giữ nguyên trạng thái chưa xác minh.

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 1 đến 12

Kỳ và người kiểm tra .....

Mục	Thực trạng hoặc mức đáp ứng	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

Phụ lục tự đánh giá tiểu mục 13 đến 18

Kỳ và người kiểm tra .....

Mục	Thực trạng hoặc mức đáp ứng	Mã minh chứng	Việc cần bổ sung
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Mục 1 ghi có/không tình trạng bất lợi. Các mục khác ghi đáp ứng/chưa đáp ứng/chưa xác minh. Trường hợp không áp dụng chỉ sử dụng khi hướng dẫn cho phép và có căn cứ. Người kiểm tra: .....

8 Nguồn và kiểm tra trước ban hành

[1] Bộ Y tế. QĐ6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016, tiêu chí A4.2, trang in 35–36.

https://trungtamytehuyentanyen.vn/public/uploads/files/quyet-djinh-6858qdj-byt-nam-2016-ve-bo-tieu-chi-chAt-luong-benh-vien-viet-nam-do-bo-truong-bo-y-te-ban-hanh_5faed01464.pdf

[2] Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15, Điều 10 và Điều 69.

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-15-2023-qh15-kham-benh-chua-benh-119231127164453959.htm

[3] Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15, hiệu lực từ 01/01/2026.

https://vbpl.vn/TW/Pages/ivbpq-lichsu.aspx?ItemID=179252&Keyword=

[4] NĐ356/2025/NĐ-CP, Điều 42 về hiệu lực và thay thế NĐ13/2023.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=187276

Ngày đối chiếu nguồn 16/10/2026. Bộ phận phụ trách xác nhận hướng dẫn kiểm tra áp dụng cho kỳ đánh giá thực tế; đối chiếu thêm TT35/2024/TT-BYT về tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện khi lập hồ sơ chất lượng chung.

□ Điền số văn bản, phiên bản, ngày áp dụng và người có thẩm quyền.

□ Chốt đầu mối, nguồn lực, lịch triển khai và mục tiêu từ thực trạng.

□ Rà soát nội dung, biểu mẫu và quy định chuyên môn, pháp lý liên quan.

□ Phê duyệt, phổ biến và kiểm tra việc áp dụng.

□ Bổ sung dữ liệu và minh chứng thật trước khi ký kết luận mức đạt.